MÓDULO 10 · MEDICAL OMNICANAL Y LÍDERES DE OPINIÓN DIGITALES

Métricas digitales

Medir la actividad digital dentro de Medical Affairs exige un salto conceptual similar al ya trabajado en el Módulo 9 para los KPIs médicos en general: las métricas de vanidad —número de seguidores, visualizaciones o clics— son fáciles de obtener pero dicen poco sobre el valor científico real generado, mientras que las métricas que verdaderamente importan exigen conectar la actividad digital con resultados de comprensión, relación o decisión clínica.

MÉTRICAS DIGITALES EN MEDICAL AFFAIRS

- Las métricas de vanidad (seguidores, visualizaciones, clics) dicen poco del valor real
- Las métricas que importan conectan la actividad digital con resultados clínicos
- Exige el mismo salto conceptual que los KPIs médicos del Módulo 9

Las métricas de actividad digital más básicas —tasas de apertura de comunicaciones, clics en enlaces, tiempo de visualización de un vídeo, finalización de un módulo de e-learning— siguen siendo útiles como indicadores de proceso: confirman que el contenido llega y genera algún nivel de interacción. Pero, como advierte la literatura especializada en comparar estrategias multicanal y omnicanal, apoyarse exclusivamente en estas métricas cuantitativas de actividad, sin complementarlas con medidas cualitativas de impacto, ofrece una imagen incompleta y puede llevar a optimizar la actividad digital hacia lo que es fácil de medir en lugar de hacia lo que realmente genera valor científico.

- Tasas de apertura, clics, tiempo de visualización, finalización de e-learning
- Útiles como indicadores de proceso: confirman que el contenido llega
- Usadas solas, dan una imagen incompleta del valor científico real

Un nivel más avanzado de medición digital busca conectar la actividad con la calidad del recorrido del HCP: analizar si un profesional que consumió contenido introductorio avanza después hacia contenido más profundo (una señal de interés genuino y creciente), si el contenido digital consumido se refleja después en preguntas más informadas durante una visita presencial con un MSL, o si la combinación de distintos canales —el patrón omnicanal descrito al inicio de este módulo— se asocia con un mayor nivel de relación y confianza científica a lo largo del tiempo, en comparación con el uso de un único canal aislado.

NIVEL 2: CALIDAD DEL RECORRIDO DEL HCP

- Si el HCP avanza de contenido introductorio a contenido más profundo
- Si el contenido digital se refleja en preguntas más informadas en las visitas
- Si combinar canales se asocia con más relación y confianza científica

Un tercer nivel, aún más exigente y menos consolidado en la práctica actual del sector, intenta vincular la actividad digital con cambios observables en la comprensión o en la práctica clínica —por ejemplo, si la exposición a contenido educativo digital sobre un gap de conocimiento identificado se asocia posteriormente con patrones de práctica más alineados con la evidencia disponible—. Establecer esta conexión de forma rigurosa exige diseños de evaluación cuidadosos y reconoce las mismas limitaciones de atribución causal discutidas en la lección sobre narrativa de impacto médico del Módulo 9.

NIVEL 3: IMPACTO EN LA PRÁCTICA CLÍNICA

- Vincula la exposición a contenido educativo con cambios en la práctica clínica
- Nivel más exigente y aún poco consolidado en la práctica del sector
- Comparte las mismas limitaciones de atribución causal del Módulo 9

Para el MSL, comprender estos niveles de medición digital —más allá de los números superficiales de alcance— le permite valorar con criterio la efectividad real de las herramientas digitales que recomienda a sus HCPs, y contribuir con perspectiva de terreno a que los equipos responsables de contenido y canales digitales prioricen la calidad del impacto científico por encima de la cantidad de interacciones superficiales.

- Permite al MSL valorar con criterio la efectividad real de las herramientas digitales
- Contribuye a priorizar la calidad del impacto sobre la cantidad de interacciones